COMPRENDRE • UE A1 / S1

Recueil et perception clinique

Observation, entretien clinique et examen physique • CM1 — source Moodle

Pourquoi recueillir des données ?

Le recueil clinique aide à comprendre la situation propre à la personne. Il associe ce que l'IDE perçoit (observation), ce que la personne rapporte (entretien) et ce que l'IDE évalue/examine (examen physique). Croiser ces données permet d'évaluer l'état de santé et l'adaptation à la situation.

Objectifs

Déterminer les besoins de santé • assurer la surveillance clinique requise • évaluer soins et traitements au fil du parcours • contribuer au travail interdisciplinaire • partager l'information utile à l'équipe.

Observer : une compétence clinique

Observer, c'est regarder avec attention et mobiliser les sens pour repérer les détails d'une personne, d'un événement ou de son environnement. En soins, l'observation est un point de départ du raisonnement clinique : elle aide à repérer un changement, une demande ou une difficulté qui n'est pas toujours exprimée.

Les conditions d'une observation de qualité

DISPONIBILITÉ	ATTENTION	CONNAISSANCES	RESPECT
Être présent, sens en éveil.	Se concentrer et écouter.	S'appuyer sur les connaissances pour analyser.	Garder discrétion et respect de la personne.

Deux formes d'observation

SPONTANÉE	DIRIGÉE / VOLONTAIRE
Survient au fil de la journée : pendant un soin, un repas, un passage dans le couloir. Peut révéler une chute ou un changement de comportement.	Part d'un objectif précis ; demande des connaissances, un temps dédié et une méthode (ex. grille) pour répondre à une question clinique.

Question réflexe

« Qu'est-ce que cette donnée peut m'apprendre sur la situation de cette personne ? » Ne pas s'arrêter au détail : chercher ce qu'il signifie et ce qu'il faut vérifier.

COMPRENDRE • OBSERVER SANS RÉDUIRE

Où porter son regard ?

Du patient à son environnement, avec méthode et sans interpréter trop tôt.

Quatre niveaux d’environnement

1 • GLOBAL	2 • TECHNIQUE	3 • ARCHITECTURAL	4 • SOCIAL
Environnement du patient dans sa globalité.	Matériel à proximité immédiate.	Chambre et état du lieu.	Famille, proches, personne de confiance.

Quoi observer ?

PERSONNE	ENVIRONNEMENT	DOSSIER
État physique et psychique ; posture, apparence, expression, comportement, vêtements et bijoux.	Aides techniques, traitements visibles, consignes, objets personnels, matériel et encombrement.	Informations complémentaires à mettre en perspective avec l’observation et la parole de la personne.

Quatre voies sensorielles • un objectif : recueillir

VOIE	EXEMPLES DE DONNÉES À DÉCRIRE
Vue	Posture, aspect/couleur de la peau, expression, vêtements, aides et matériel présent.
Ouïe	Toux, ronflement, sifflement, bruits intestinaux, alarmes/bruits du matériel ou du lieu.
Odorat	Odeurs corporelles, urines/selles, plaie/pansement, tabac, haleine inhabituelle.
Toucher	Température et rugosité de la peau, sécrétions, texture d’un textile ; dans le respect du soin et du consentement.

Décrire avant de conclure

Séparer le fait perçu de l’interprétation. Exemple : « sifflement audible à l’expiration » est une donnée ; « aggravation respiratoire » est une hypothèse à vérifier par d’autres éléments.

COMPRENDRE • DE LA PAROLE À L'EXAMEN

Entretien + examen physique

Deux temps complémentaires qui construisent une compréhension clinique.

Entretien clinique : ce que la personne rapporte

Interroger la personne et, avec pertinence, son entourage ou sa famille sur l'histoire de santé et le motif, les antécédents utiles, l'environnement social et physique, les symptômes et les traitements. Le contexte de l'entretien compte (lieu, urgence, disponibilité, confidentialité).

Posture relationnelle

Empathie • congruence • bienveillance • communication verbale et non verbale. Laisser la personne raconter, préciser ses mots, vérifier la compréhension et respecter son rythme.

Examen physique : ce que l'IDE évalue

TEMPS	GESTE	REPÈRES
1 • Inspection	Observer avec soin ; sens mobilisés, examen direct ou indirect avec instrument.	Aspect, posture, mouvements, éléments visibles.
2 • Palpation	Toucher, palpation légère ou profonde selon indication et compétences.	Température, pulsations, humidité, texture.
3 • Auscultation	Écouter les bruits produits par les organes, avec stéthoscope.	Cœur, poumons, intestins.
4 • Percussion	Percuter une surface corporelle afin de produire des sons.	Les sons varient selon la densité du tissu sous-jacent.

Données subjectives et objectives

Subjectif : symptômes, vécu et paroles de la personne. Objectif : signes observés/mesurés. Les examens complémentaires (paramètres vitaux, ECG, glycémie, biologie, imagerie) s'intègrent au cadre de compétences et, si requis, à la prescription médicale.

Rôle IDE : recueillir avec intention, expliquer le geste, préserver pudeur et confort, respecter le consentement et ne réaliser que les examens relevant de sa compétence. Une donnée préoccupante ou un changement clinique appelle une évaluation, une transmission et, si nécessaire, une alerte.

COMPRENDRE • QUALITÉ ET PRUDENCE

Biais, limites et réflexivité

L’observation s’apprend : faits, croisement des sources et regard d’équipe.

Pourquoi l’observation peut-elle être incomplète ?

LIÉES À L’OBSERVATEUR	LIÉES À LA PERSONNE	LIÉES AU CONTEXTE
Capacités sensorielles variables • fatigue/surcharge • difficulté à verbaliser/transmettre • biais cognitifs.	Certains éléments peuvent être masqués ; la présence d’un observateur peut modifier les réactions.	Bruit, lumière ou lieu peu adapté.

Biais cognitifs : ralentir le jugement

Raccourcis de pensée, souvent automatiques, qui peuvent déformer la perception et conduire à des jugements rapides sans analyse suffisante des faits. Le cours illustre notamment la confirmation (chercher surtout les éléments qui confortent une hypothèse), la négativité et l’ancrage (donner trop de poids à un premier élément).

Stratégie en 3 étapes

1. Admettre que chacun peut être sujet à des biais. 2. Identifier le biais et son effet sur la perception/décision. 3. Questionner l’automatisme et envisager des interprétations alternatives.

Check-list de recueil clinique

FAITS	CROISEMENT	RÉÉVALUATION	ÉQUIPE
Décrire ce qui est perçu avant d’interpréter.	Mettre en lien observation, entretien, examen et dossier.	Comparer dans le temps ; repérer changement et tendance.	Partager les faits, accepter doute et controverse.

Exemple de raisonnement

« Toux et sifflement entendus » : préciser quand et comment ; demander à la personne ce qu’elle ressent ; observer l’effort et le contexte ; réaliser/consulter les évaluations dans le cadre autorisé ; comparer aux données antérieures ; transmettre les éléments utiles. Une donnée isolée prend sens lorsqu’elle est reliée aux autres.

À retenir : recueillir → décrire → croiser → interpréter avec prudence → transmettre. L’IDE est aussi observé par la personne et ses proches : relation, explications, respect et écoute font partie de la situation de soin.

Source : Moodle, CM1 « Recueil et perception clinique », UE A1/S1, promotion 2026–2029. Bibliographie du support : Loïc Martin, Le raisonnement clinique — guide méthodologique, Elsevier Masson, 2019 ; Jean-Louis Pedinielli & Lydia Fernandez, L’observation clinique et l’étude de cas, Armand Colin/Dunod, 4e éd. ; cours IFAS Ollioules ; ressource Cairn citée par le cours.